Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
Primeira Vara

Autos: 0801196-09.2021.8.12.0007

Requerente: Conceição Aparecida do Amorim

Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer intentada por Conceição Aparecida do Amorim em face de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Cassilândia, alegando que é portadora de obesidade mórbida, hipertensão arterial sistêmica, varizes de membros inferiores com ulceração de difícil controle associado a edema, necessitando fazer uso contínuo e por tempo indeterminado dos seguintes medicamentos: xarelto 20mg, diosmin 450/50mg, cilostazol 20 mg e kolagenase+cloranfenicol pomada, conforme prescrição médica.

Aduz que além destes medicamentos, faz uso de espironolactona 25mg, enalapril 10mg, furosemida 40mg e sulfadiazina de prata, sendo estes fornecidos pela assistência farmacêutica de Cassilândia.

Segundo a médica que acompanha a autora, esta já fez uso de medicamentos disponíveis no SUS, heparina sódica, porém, este não possui a mesma eficácia do tratamento indicado. Afirma ainda, que o medicamento é de alto custo, com o qual a autora não consegue suportar apenas com o valor de sua aposentadoria.

Junta documentos (págs. 11/26).

Juntou-se parecer do NAT nas fls. 44/54.

Conforme decisão de fls. 41/44, foi deferida tutela de urgência, determinando aos requeridos a concessão do medicamento pleiteado à autora.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação nas fls. 56/72, alegando, preliminarmente, necessidade de inclusão da União para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. No mérito, pugna pela aplicação da Tese firmada pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.

Já o Município, por sua vez, apresentou contestação nas fls. 96/113, alegando, preliminarmente, necessidade da União no pólo passivo. No mérito, sustenta que o medicamento não foi incorporado pelo SUS, e não se comprovou a necessidade de utilização do medicamento em detrimento das opões fornecidas pelo SUS.

Em impugnação às contestações de fls. 73/88 e 109/119, a parte autora rebate os argumentos da requerida e ratifica a pretensão inicial.

Relatado. Decido.

A matéria *sub judice* é eminentemente de direito e as provas que guarnecem o feito são plenamente suficientes, pelo que passo, de pronto, ao exame da lide, nos moldes do art. 355, I, da Lei 13.105, de 16.03.2015 (NCPC).

Apesar dos requeridos alegarem, em sede preliminar, a necessidade de inclusão da União no pólo passivo, tal preliminar deve ser afastada.

O Supremo Tribunal Federal publicou, em 11/10/2024, o acórdão de mérito do RE 1366243, objeto do Tema 1234, cuja tese foi fixada nos seguintes termos:

> *"I – Competência*
> *1) Para fins de fixação de competência, as* ***demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal****, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,* ***quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos****, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.

10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) ***No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s)****, independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.*

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, ***é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União****, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.*

(...)

VIII – Modulação de efeitos tão somente quanto à Competência: ***somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco****, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.*

IX. Proposta de Súmula Vinculante:

"O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)".

Assim, no referido julgado ficou, em resumo, definida que a competência para processar e julgar demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, mas registrados na ANVISA, depende do custo anual do tratamento,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.

cabendo à Justiça Estadual as ações cuja soma anual seja inferior a 210 salários mínimos e, à Justiça Federal medicamentos que sejam iguais ou ultrapassem este montante.

Além disso, este processo foi ajuizado em 09.12.2021, de modo que, à luz do Tema n.º 1.234, a competência para o processamento e julgamento da presente demanda é da Justiça Estadual.

Portanto, em conformidade com o Tema n. 1.234 do STF, não deve ser acolhida a preliminar para inclusão da União no pólo passivo.

Com relação ao mérito, em sede de repercussão geral, o STF julgou os temas n.º 1234 e 6, fixando-se o seguinte:

> *"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. (...) II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. (...) IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC),* ***o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.*** *4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.

conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) ***Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.*** *"*

"Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. (...) Tese de julgamento: 1. ***A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo****. 2. É possível,* ***excepcionalmente****, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,* ***desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa****, nos termos do item "4" do Tema 1.234 da repercussão geral;* ***(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação****, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;* ***(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.

> ***clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento****. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS." (Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Publicação: 28/11/2024, RE 566471, TEMA n.º 6).* (grifo nosso)

Assim, conforme tese fixada pela Corte Suprema infere-se que houve grande limitação à concessão de medicamentos não incluídos no RENAME por meio de decisões judiciais, visto que diversos requisitos devem ser preenchidos, cumulativamente, para concessão judicial de medicamento, sendo eles: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.

medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado e; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Observando-se tais diretrizes, no caso concreto, conforme parecer do NAT de fls. 30/40, os medicamentos pleiteados estão registrados na ANVISA, mas nenhum deles é padronizado no RENAME ou outro normativo do SUS.

> **IV - Tratando-se de medicamento, deverá referir-se também a classe medicamentosa do fármaco e seu registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);**
>
> A Rivaroxabana (antitrombótico), Diosmina + Hesperidina (antivaricosos de ação sistêmica), Cilostazol (antitrombótico), Colagenase + Cloranfenicol (cicatrizante) estão registrados na ANVISA.

> **VII - Se o pedido do autor é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em qualquer esfera, considerando especialmente, no caso de fármacos, os Programas de Medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Protocolos Clínicos e a eficácia dos remédios disponibilizados na rede pública;**
>
> A Rivaroxabana, Diosmina + Hesperidina, Cilostazol, Colagenase + Cloranfenicol não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2020).
>
> A Rivaroxabana foi avaliada pela CONITEC no Relatório de recomendação nº 195 − Apixabana, rivaroxabana e dabigatrana em paciente com fibrilação atrial não valvar (CONITEC, fevereiro/2016), doença diferente da apresentada pela paciente.

No caso, não restou comprovada a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como a ineficácia daqueles fornecidas pelo SUS, conforme mencionado pelo NAT, quais sejam.

> **IX - Sugerir medicamentos ou tratamentos similares ao requerido, preferencialmente existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de comprovada e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de uso e comparação de custo orçamentário;**
>
> A RENAME 2020 tem padronizado no Componente Básico de Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos anticoagulantes (Heparina, Varfarina), antiagregante plaquetário (Ácido Acetilsalicílico), cicatrizante (Sulfadiazina de Prata), emoliente tópico (Óleo Mineral)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
Primeira Vara

Extrai do relatório médico juntado à fls. 18/20, a ausência de indicação de qualquer de outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos terapêuticos ou tratamentos já realizados e os motivos da imprescindibilidade dos remédios pleiteados em razão da impossibilidade de sua substituição, limitando-se a mencionar que os medicamentos receitados seriam insubistituíveis, sem qualquer menção às opções terapêuticas fornecidas pelo SUS.

As medicações são insubstituíveis, sendo a única alternativa para o tratamento de patologia grave que pode cursar com complicações diversas, inclusive óbito.
É necessário uso contínuo de tais medicações afim de evitar novos quadros embólicos.

Ainda, a requerente não trouxe evidências científicas que possam dar base à análise do pleito, muito menos fundamentou qualquer argumento quanto à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação.

Diante do exposto, não preenchido os requisitos do Tema vinculante 1.234 do STF, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, verba esta que deverá permanecer suspensa a exibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do Código de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
Primeira Vara

Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da Justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Se apresentada apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, em 15 dias. Se apresentada apelação adesiva junto com as contrarrazões, intime-se o apelante contrarrazoá-la, em 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do(s) recurso(s).

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.

Cassilândia-MS, 28 de agosto de 2025.

Flávia Simone Cavalcante
Juíza de Direito
Assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/08/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801196-09.2021.8.12.0007 e código ARkDvv1v.